

Sujet 19

DÉSHYDRATATIONS AIGUES DE L'ENFANT

DR Chokri Chouchane

Service de pédiatrie de Monastir

INTRODUCTION - DEFINITION

- ❖ **Déficit aigu non compensé en eau et en électrolytes**
- ❖ **Complique souvent une gastroentérite aiguë.**
- ❖ **Pronostic choc hypovolémique**
- ❖ **Urgence thérapeutique**
- ❖ **Pronostic amélioré par l'utilisation des SRO**

COMPARTIMENTS HYDRIQUES DE L'ORGANISME

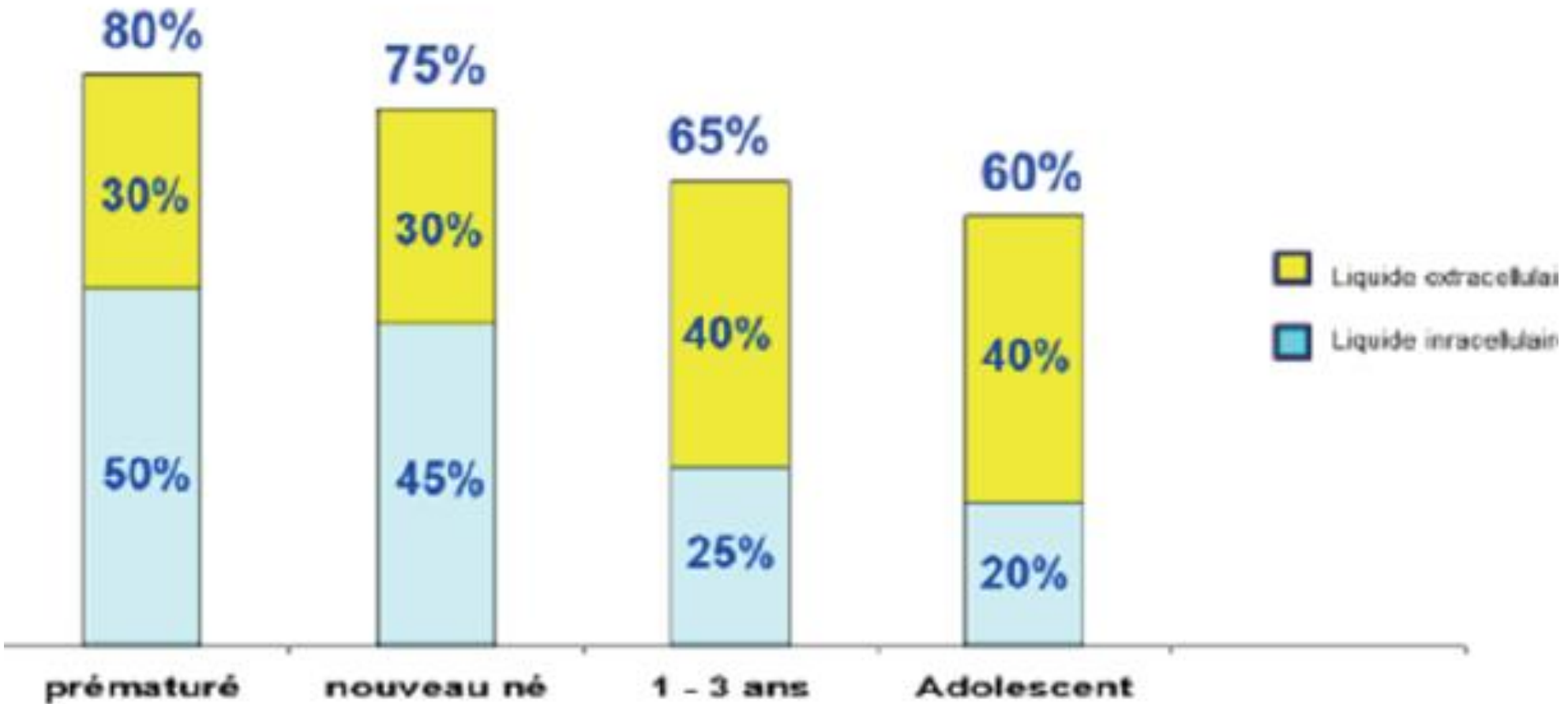


Figure 2 : Évolution des compartiments hydriques au cours de la croissance

DIAGNOSTIC POSITIF

Item \ Score	0	1	2
Langue	Humide	Un peu desséchée	Sèche
Globes oculaires	Normaux	Légèrement enfoncés	Très enfoncés
Fontanelle	Plate	Légèrement déprimée	Très déprimée
Extrémités	Chaudes	Refroidies	Violacées
État neurologique	Normal	Plaintif	Apathique
Respiration	Calme	Rapide > 40 /min	Ample et rapide
Pli cutané	Absent	Pâteux	Persistant

Rajouter 5 points si choc ou altération de la conscience

Score : 0 – 3 : stade I : pertes < 5 %

Score : 4 – 8 : stade II : pertes : 5 – 10 %

Score : 9 - 19 : stade III : pertes > 10 %

QCM

Q1: La déshydratation aiguë du nourrisson:

- A. Est définie par un déficit non compensé en eau et en électrolytes**
- B. Est définie par un déficit non compensé en eau**
- C. Complique, le plus souvent, une gastroentérite aiguë**
- D. Le pronostic est conditionné par le risque de choc infectieux**
- E. Le pronostic a été amélioré par l'utilisation des SRO**

Q1: La déshydratation aigue du nourrisson:

- A. Est définie par un déficit non compensé en eau et en électrolytes**
- B. Est définie par un déficit non compensé en eau**
- C. Complique, le plus souvent, une gastroentérite aigue**
- D. Le pronostic est conditionné par le risque de choc infectieux**
- E. Le pronostic a été amélioré par l'utilisation des SRO**

Q2 : La composition des compartiments hydriques chez le nourrisson se caractérise par :

- A. L'eau totale représente 75% du poids corporel**
- B. L'eau totale représente 65% du poids corporel**
- C. L'eau extracellulaire représente 50% du poids corporel**
- D. L'eau extracellulaire représente 40% du poids corporel**
- E. L'eau intracellulaire représente 30 à 40% du poids corporel**

Q2 : La composition des compartiments hydriques chez le nourrisson se caractérise par :

- A. L'eau totale représente 75% du poids corporel**
- B. L'eau totale représente 65% du poids corporel**
- C. L'eau extracellulaire représente 50% du poids corporel**
- D. L'eau extracellulaire représente 40% du poids corporel**
- E. L'eau intracellulaire représente 30 à 40% du poids corporel**

Q3: Parmi les facteurs qui expliquent la susceptibilité des nourrissons au risque de déshydratation aigue on retient :

- A. La proportion élevée qu'occupent l'eau totale intracellulaire (50% de l'eau totale)**
- B. Les besoins hydriques élevés par comparaison à l'adulte et au grand enfant**
- C. Un taux de renouvellement de la composante liquidienne de l'organisme beaucoup plus lent**
- D. Une immaturité de la fonction rénale avec des difficultés de concentration des urines**
- E. Une dépendance de son entourage quant à ses apports en eau et en sels minéraux.**

Q3: Parmi les facteurs qui expliquent la susceptibilité des nourrissons au risque de déshydratation aiguë on retient :

- A. La proportion élevée qu'occupent l'eau totale intracellulaire (50% de l'eau totale)**
- B. Les besoins hydriques élevés par comparaison à l'adulte et au grand enfant**
- C. Un taux de renouvellement de la composante liquidienne de l'organisme beaucoup plus lent**
- D. Une immaturité de la fonction rénale avec des difficultés de concentration des urines**
- E. Une dépendance de son entourage quant à ses apports en eau et en sels minéraux.**

Q4: En faveur de la déshydratation extra-cellulaire on retient:

A. Le pli cutané

B. La sècheresse des muqueuses

C. La dépression de la fontanelle antérieure

D. Crises convulsives

E. L'oligurie

Q4: En faveur de la déshydratation extra-cellulaire on retient:

A.Le pli cutané

B.La sècheresse des muqueuses

C.La dépression de la fontanelle antérieure

D.Crises convulsives

E.L'oligurie

Q5 : En faveur de la déshydratation intracellulaire on retient :

A. La fièvre

B. Les troubles de la conscience

C. La soif intense

D. La sècheresse de la langue

E. Oligurie

Q5 : En faveur de la déshydratation intracellulaire on retient :

A. La fièvre

B. Les troubles de la conscience

C. La soif intense

D. La sècheresse de la langue

E. Oligurie

Q6 : En faveur de la déshydratation sévère (stade III) on retient :

A. Une perte pondérale entre 5 et 10%

B. Hyponatrémie < 125 meq/L

C. Hypokaliémie $< 3,5$ meq/L

D. Un déficit hydrique > 100 ml/kg/j

E. Un score de déshydratation > 8

Q6 : En faveur de la déshydratation sévère (stade III) on retient :

A. Une perte pondérale entre 5 et 10%

B. Hyponatrémie < 125 meq/L

C. Hypokaliémie $< 3,5$ meq/L

D. Un déficit hydrique > 100 ml/kg/j

E. Un score de déshydratation > 8

Q7 : La réhydratation orale doit être privilégiée en dehors de :

A. Acidose métabolique

B. Déshydratation avec un déficit hydrique $>10\%$

C. Hyponatrémie < 125 meq/L

D. Troubles de la conscience

E. Suspicion d'une urgence chirurgicale

Q7 : La réhydratation orale doit être privilégiée en dehors de :

A. Acidose métabolique

B. Déshydratation avec un déficit hydrique >10%

C. Hyponatrémie < à 125 meq/L

D. Troubles de la conscience

E. Suspicion d'une urgence chirurgicale

Q8 : Le traitement de la déshydratation légère (Stade 1) consiste à :

- A. Administrer la SRO en prises fractionnées pour compenser la totalité de 50 à 100 ml/kg en 4-6**
- B. Arrêter l'allaitement maternel pendant 4 à 6 heures**
- C. Arrêter le lait artificiel pendant 4 à 6 heures**
- D. Compenser le déficit hydrique sur 12 h en cas d'hyponatrémie**
- E. Arrêter la réhydratation orale après la normalisation de l'état d'hydratation**

Q8 : Le traitement de la déshydratation légère (Stade 1) consiste à :

- A. Administrer la SRO en prises fractionnées pour compenser la totalité de 50 à 100 ml/kg en 4-6**
- B. Arrêter l'allaitement maternel pendant 4 à 6 heures**
- C. Arrêter le lait artificiel pendant 4 à 6 heures**
- D. Compenser le déficit hydrique sur 12 h en cas d' hyponatrémie**
- E. Arrêter la réhydratation orale après la normalisation de l'état d'hydratation**

Q9 : La réhydratation parentérale consiste à :

- A. Un remplissage vasculaire par du sérum physiologique isotonique à 9‰ 20ml/kg**
- B. Une perfusion de sérum glucosé à 5% avec, par 500 ml 76mEq/l**
- C. Administrer la moitié des pertes les premières 4 heures**
- D. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hyponatrémique**
- E. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hypernatrémique**

Q9 : La réhydratation parentérale consiste à :

- A. Un remplissage vasculaire par du sérum physiologique isotonique à 9‰ 20ml/kg**
- B. Une perfusion de sérum glucosé à 5% avec, par 500 ml 76mEq/l**
- C. Administrer la moitié des pertes les premières 4 heures**
- D. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hyponatrémique**
- E. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hypernatrémique**

Q10 : La réalimentation dans la déshydratation légère consiste à :

- A. Poursuivre l'allaitement maternel pendant la réhydratation.**
- B. Reprendre l'allaitement artificiel après 4 heures de réhydratation orale.**
- C. Reprendre l'alimentation avec un hydrolysat de protéines du Lait de vache (Pepti Junior®) chez les nourrissons âgés entre 3 et 6 mois.**
- D. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les aliments riches en fibres**
- E. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les glucides complexes**

Q10 : La réalimentation dans la déshydratation légère consiste à :

- A. Poursuivre l'allaitement maternel pendant la réhydratation.**
- B. Reprendre l'allaitement artificiel après 4 heures de réhydratation orale.**
- C. Reprendre l'alimentation avec un hydrolysat de protéines du Lait de vache (Pepti Junior®) chez les nourrissons âgés entre 3 et 6 mois.**
- D. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les aliments riches en fibres**
- E. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les glucides complexes**

Q11 : Parmi les complications immédiates de la déshydratation on retient :

A. Insuffisance cardiaque

B. L'état de choc hypovolémique

C. La thrombose des veines intracrâniennes

D. Les crises convulsives

E. L'hématome sous dural

Q11 : Parmi les complications immédiates de la déshydratation on retient :

A. Insuffisance cardiaque

B. L'état de choc hypovolémique

C. La thrombose des veines intracrâniennes

D. Les crises convulsives

E. L'hématome sous dural

Q12 : Parmi les complications tardives de la déshydratation on retient :

A. La dénutrition

B. L'insuffisance surrénalienne

C. L'hématome sous dural

D. La thrombose des veines rénales

E. Le retard mental

Q12 : Parmi les complications tardives de la déshydratation on retient :

A. La dénutrition

B. L'insuffisance surrénalienne

C. L'hématome sous dural

D. La thrombose des veines rénales

E. Le retard mental

Q13 : Parmi les moyens de prévention de la déshydratation on retient :

A.L'allaitement maternel

B.L'alimentation avec un lait artificiel sans lactose

**C.L'alimentation avec un hydrolysate de protéines du
Lait de vache (Pepti Junior®)**

D.L'antibioprophylaxie

E.Réhydratation orale en cas de diarrhée aigue

Q13 : Parmi les moyens de prévention de la déshydratation on retient :

A.L'allaitement maternel

B.L'alimentation avec un lait artificiel sans lactose

**C.L'alimentation avec un hydrolysate de protéines du
Lait de vache (Pepti Junior®)**

D.L'antibioprophylaxie

E.Réhydratation orale en cas de diarrhée aiguë

CAS CLINIQUE

- ❖ **Un nourrisson âgé de 9 mois sans antécédents pathologiques notables amené pour diarrhée faite des selles liquidiennes à raison de 6 selles par jour évoluant depuis 2 jours associée à une fièvre à 38,5 °C sans de vomissements.**
- ❖ **Pas des cas similaires dans la famille**
- ❖ **À l'examen :**
 - **Température 38,7 °C**
 - **Fréquence cardiaque : 100 b/min**
 - **Fréquence respiratoire : 50/min**
 - **Extrémités : chaudes**
 - **Pli cutané pâteux**
 - **Fontanelle antérieure légèrement déprimée**
 - **Bon état neurologique**

**Q1 : Le score de déshydratation
pour ce nourrisson est à :**

A.2

B.3

C.4

D.5

E.6

CAS CLINIQUE

- ❖ Un nourrisson âgé de 9 mois sans antécédents pathologiques notables amené pour diarrhée faite des selles liquidiennes à raison de 6 selles par jour évoluant depuis 2 jours associée à une fièvre à 38,5 °C sans de vomissements.
- ❖ Pas des cas similaires dans la famille
- ❖ À l'examen :
 - Température 38,7 °C
 - Fréquence cardiaque : 100 b/min
 - Fréquence respiratoire : 50/min : 1
 - Extrémités : chaudes
 - Pli cutané pâteux : 1
 - Fontanelle antérieure légèrement déprimée : 1
 - Bon état neurologique

**Q1 : Le score de déshydratation
pour ce nourrisson est à :**

A.2

B.3

C.4

D.5

E.6

Q2 : La conduite à tenir consiste à :

A. Hospitaliser le nourrisson

B. Administrer une SRO : 5-10 ml toutes les 1-2 minutes

C. Prescrire une antibiothérapie

D. Arrêter le lait artificiel pendant 12 heures

E. Arrêter l'allaitement maternel 4 heures

Q2 : La conduite à tenir consiste à :

A. Hospitaliser le nourrisson

B. Administrer une SRO : 5-10 ml toutes les 1-2 minutes

C. Prescrire une antibiothérapie

D. Arrêter le lait artificiel pendant 12 heures

E. Arrêter l'allaitement maternel 4 heures

CAS CLINIQUE

Le nourrisson a été réadressé à domicile. 24 heures après son retour il a présenté des vomissements alimentaires 3 fois par jour. Les parents ont reconsulté.

- ❖ À l'examen il était apyrétique
- ❖ Score de déshydratation à 6
- ❖ Urée sanguine : 9 mmol/L
- ❖ Créatinine sanguine : 60 μ mol/L
- ❖ Natrémie : 142 mmol/L kaliémie : 3,8 mmol/L
- ❖ pH : 7,32 HCO_3^- : 19 mmol/L

Q3: Les pertes hydriques sont estimées à:

A.4%

B.7%

C.11%

D.13%

E.15%

Q3: Les pertes hydriques sont estimées à:

A.4%

B.7%

C.11%

D.13%

E.15%

Q4 : La conduite à tenir consiste à :

A. Hospitaliser le nourrisson

B. Remplissage vasculaire

C. Administrer des bicarbonates de sodium

D. Commencer la réhydratation par voie orale

E. Administrer la moitié des pertes en 12 heures

Q4 : La conduite à tenir consiste à :

A. Hospitaliser le nourrisson

B. Remplissage vasculaire

C. Administrer des bicarbonates de sodium

D. Commencer la réhydratation par voie orale

E. Administrer la moitié des pertes en 12 heures

CAS CLINIQUE

Au cours de l'hospitalisation aggravation de la diarrhée à raison de 12 selles liquidiennes par jour.

❖ La fréquence cardiaque est à 120 /minute le TRC est à 5 secondes les extrémités sont froides et la TA est à 65/35.

❖ Urée sanguine : 12 mmol /L

❖ Créatinine sanguine : 75 µmol/L

❖ Natrémie : 155 mmol/L kaliémie : 3,7 mmol/L

❖ pH : 7,30 HCO₃⁻ : 18 mmol /L

Q5 : Quelles votre conduite à tenir :

- A. Administrer du sérum physiologique 10 ml/kg à Flot**
- B. Administrer du sérum physiologique 20 ml/kg à Flot**
- C. Après amélioration de l'état hémodynamique administrer du sérum glucosé 5% avec 76 meq/L du NaCl, 1 ampoule de KCL et 1 ampoule de gluconate de calcium**
- D. Administrer la moitié des pertes en 4 heures puis la moitié des pertes + besoins en 20 heures**
- E. Administrer la moitié des pertes + besoins en 24 heures**

Q5 : Quelles votre conduite à tenir :

- A. Administrer du sérum physiologique 10 ml/kg à Flot**
- B. Administrer du sérum physiologique 20 ml/kg à Flot**
- C. Après amélioration de l'état hémodynamique administrer du sérum glucosé 5% avec 76 meq/L du NaCl, 1 ampoule de KCL et 1 ampoule de gluconate de calcium**
- D. Administrer la moitié des pertes en 4 heures puis la moitié des pertes + besoins en 20 heures**
- E. Administrer la moitié des pertes + besoins en 24 heures**